EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – VALORACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La posibilidad de tener una expectativa de vida mayor en la población es una realidad por la que está pasando muchos países, esto gracias a los logros en los temas sociales y económicos. Sin embargo, el crecimiento de la población adulta mayor tiene un ritmo acelerado y este es mayor en los países en desarrollo (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2022). Ejemplo de esto es que a nivel mundial para el año 2020 la población de 60 años y más superaron los niños menores de 5 años; al término de la década 2020-2030 las personas de 60 años y más tendrá un aumento de 34 % y para el 2050 alcanzaría los 2 100 millones de personas. Siendo las regiones con mayor crecimiento África, América Latina y el Caribe y Asia, en donde se encontrarán casi el 80 % de las personas de este grupo etario (OPS, 2022). En el documento *Década del Envejecimiento Saludable* se sugiere que las personas mayores tengan una atención coordinada y centrada en la persona, con el objetivo de optimizar su capacidad funcional, además, la atención necesaria en caso de pérdida significativa de la capacidad intrínseca (OPS, 2022). El mantener a las personas de 60 años y más funcionales es un trabajo arduo ya que debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de este grupo, las inequidades, los estereotipos, el entorno y su propia perspectiva de funcionalidad; pero de lograr esta meta este grupo puede realizar contribuciones fundamentales a la sociedad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). Por su parte en Costa Rica el Ministerio de Salud (MINSA) creó la *Estrategia Nacional para el Envejecimiento saludable basado en el curso de vida 2018-2020* y su posterior actualización para los años 2022-2026. Dentro de esta última se encuentra un ámbito de actuación relacionado con esta intervención “prestar servicios de atención integrada y atención primaria de salud centrados en la persona, que respondan a las necesidades de las personas adultas mayores” (Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA], 2023), con la visión de que conforme se avanza en el curso de la vida, las necesidades en salud tienden a ser crónicas y complejas por lo que este tipo de atención se vuelve más eficaz que el tipo en donde se enfoca en enfermedades específicas. Desde el alcance que tiene la CCSS y para articularse con los documentos internacionales en el tema, se creó el *Protocolo de Atención clínica para la aplicación del énfasis a la persona adulta mayor en el Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES) para el Primer Nivel de Atención*, el cual tiene como objetivo que se valore la capacidad funcional de la persona adulta mayor desde el primer nivel de atención y que esta permita realizar un plan integral, integrado, continuado y articulado en red, todo lo anterior con el enfoque centrado en la persona. Respecto a la legislación en Costa Rica, existen varias leyes que se relacionan al tema, sin embargo, la Ley para la Persona Adulta Mayor (Nº 7935) es la que define acciones al MINSA para la atención integral a esta población y así garantizar el nivel óptimo del bienestar en todas sus esferas. La CCSS se alineó a esta ley desde 2016 y la integró en su plan de acción (MINSA, 2023).

Evidencia	El mantener y fomentar la capacidad funcional durante el curso de vida permite que las personas de 60 años y más tengan bienestar (OMS, 2015); sin embargo, para lograrlo se tiene que tomar en cuenta la capacidad funcional de la persona, que comprende todo lo relacionado con su salud y capacidad de tomar las decisiones importantes para ella; esta se encuentra muy relacionada con la capacidad intrínseca, que es la unión de las capacidades físicas y mentales; y por último se encuentra el entorno, el cual no es menos importante. La ubicación geográfica, el hogar, la comunidad y la sociedad juegan un papel muy importante para las capacidades anteriormente citadas. Por otra parte, al ver como la capacidad intrínseca se desarrolla permite evaluar a las personas y predecir sus posibles trayectorias (se mantiene o disminuye), con base en los datos relacionados con: los hábitos, características de salud, genética y factores personales (OMS, 2015). Esta evaluación de datos puede ayudar a realizar planes de acción para mitigar los efectos relacionados. Las evidencias encontrada son (U.S. Preventive Services TASK FORCE, s.f.): • Tamizaje de depresión en el adulto mayor (grado B). • Tamizaje de abuso de drogas (grado B). • Tamizaje por hipertensión arterial (grado A) • Consejería para promover la salud dietética y actividad física en personas con riesgo cardiovascular (grado B) • Intervenciones para la prevención de caídas en la comunidad (grado B).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Capacitación deficiente de los colaboradores asistenciales en el tema de adulto mayor y su valoración. Estrategias: Capacitación continua para los colaboradores asistenciales en el tema de adulto mayor y su valoración.
Normativa Técnica	• Protocolo de Atención clínica para la aplicación del énfasis a la persona adulta mayor en el Sistema Integrado de Expediente en salud (SIES) para el Primer Nivel de Atención. • Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable, Basado en el curso de vida 2022-2026.
Costo / Efectividad	El poder llegar a los 60 años o más no es sinónimo de enfermedad, y por tanto tampoco es de altos costos en servicios de salud, por lo que el enfoque en el curso de vida y mantenimiento de salud a esa edad es fundamental para tener una vejez saludable en donde se pueda contribuir a la sociedad (OPS, 2022). Las intervenciones que procuran una abordaje preventivo asociado a un enfoque: geriátrico, integral, sanitario y anticipado, son costo efectivas e implican actuaciones disponibles en el contexto de buenas prácticas en salud, que no requieren de tecnologías (Ministerio de Salud Pública de Uruguay, 2018). En diferentes estudios, la prevención y el tratamiento oportuno de la pérdida de la visión está entre las intervenciones de salud más costo-efectivas entre ellas está el grupo de catarata y retinopatía diabética en adulto mayor, al compararlo con otras patologías (Ministerio de Salud del Perú, 2013).

Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar el porcentaje de personas de 65 años y más a las que se les atiende y tamiza por medio del énfasis de adulto mayor en el primer nivel de atención, para contribuir a mejorar las estrategias de acceso a los servicios de salud y valoración de riesgo, de manera que se pueda incidir en los factores protectores del envejecimiento y la salud, aplicando un enfoque de curso de vida.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la diferencia entre áreas de salud respecto a la cobertura de atención de personas de 65 años y más en el primer nivel de atención? ¿Cuál es el porcentaje de personas de 65 años y más a las que se le realizó el énfasis de adulto mayor en el primer nivel de atención y la diferencia entre áreas de salud? ¿Cuál es la variación interanual de la cobertura de personas de 65 años y más con atención bajo el énfasis de adulto mayor en el primer nivel de atención?
Indicadores asociados a la intervención	04-01-1.0 Cobertura de personas de 65 años y más atendidas bajo el énfasis de adulto mayor.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Protocolo de Atención clínica para la aplicación del énfasis a la persona adulta mayor en el Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES) para el Primer Nivel de Atención. San José: CCSS. Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA]. (2023). Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable, basado en el curso de vida 2022-2026. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/ministerio-de-salud/planes-y-politicas-institucionales/planes-estrategicos-institucionales/5079-estrategia-nacional-para-un-envejecimiento-saludable-2018-2020/file Ministerio de Salud del Perú. (julio de 2013). Plan Estratégico Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera Evitable (2014-2021). https://www3.paho.org/per/images/stories/FtPage/2013/PlanENSOPC-RD-6julio2013_1v.pdf Ministerio de Salud Pública de Uruguay. (2018). Recomendaciones-Guía Nacional, Abordaje Integral de Caídas en el Adulto Mayor Prevención, Diagnóstico y Tratamiento. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-saludpublica/files/documentos/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20ca%C3%ADdas.pdf Organización Mundial de la Salud [OMS]. (29 de septiembre de 2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241565042 Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (14 de junio de 2022). Década del envejecimiento Saludable 2020-2030. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-proposal-final-apr2020rev-es.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_25&download=true U.S. Preventive Services TASK FORCE [USPSTF]. (s.f.). Recommendations. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/topic_search_results?searchterm=senior&topic_status=All&PAGE=1